

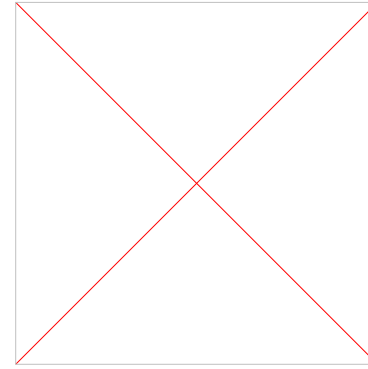
INCLUSÃO NA IGREJA

Novo símbolo da inclusão



TRANSTORNO VS SÍNDROME

Na medicina e na psicologia, os termos **síndrome** e **transtorno** são usados para classificar condições de saúde com base no quanto se sabe sobre suas causas e como elas se manifestam.





1. Síndrome

- Uma **síndrome** é um conjunto de sinais (o que o examinador ou médico observa no corpo) e sintomas (o que a pessoa sente) que acontecem ao mesmo tempo e caracterizam uma determinada condição de saúde.
- **Causas genéricas ou múltiplas:** Uma síndrome pode ter diferentes origens — genéticas, metabólicas, emocionais ou ambientais.
- **EX:** Síndrome de Down (Trissomia do 21), Síndrome do X Frágil, Síndrome de Turner, Síndrome de Tourette





2. Transtorno

Um **transtorno** é um termo amplo usado na área da saúde mental e do neurodesenvolvimento para descrever uma alteração funcional no modo como o cérebro opera, afetando pensamentos, emoções, comportamentos ou a capacidade de aprendizagem e adaptação.

Ao contrário de uma doença com lesão física visível em exames de imagem ou sangue, o transtorno é diagnosticado pelo **padrão de funcionamento e impacto no dia a dia**

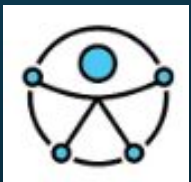


- **Prejuízo funcional:** Para ser considerado um transtorno, o padrão de comportamento ou processamento mental deve causar sofrimento significativo ou interferir na rotina diária (na escola, no trabalho ou nas relações sociais).
- **Origem multifatorial:** Envolve uma combinação de fatores genéticos, neurobiológicos e ambientais, sem uma "causa única" isolada.
- **Diagnóstico clínico:** É estabelecido por meio da observação do comportamento, histórico de vida e aplicação de critérios padronizados

Exemplos Práticos

- **Transtornos do Neurodesenvolvimento:** Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH),
- **Transtornos de Aprendizagem:** Dislexia, Discalculia, Disgrafia.
- **Transtornos Emocionais e de Humor:** Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), Transtorno Depressivo Maior, Transtorno Bipolar.





Autismo - Deficiência Intelectual - Síndrome de Down

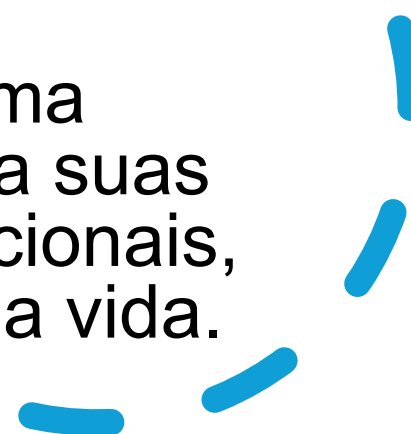


Embora frequentemente confundidos por estarem relacionados ao neurodesenvolvimento, o **Autismo (TEA)**, a **Síndrome de Down** e a **Deficiência Intelectual** são condições distintas, com origens, critérios diagnósticos e características particulares. Uma mesma pessoa, inclusive, pode apresentar mais de uma dessas condições associadas.



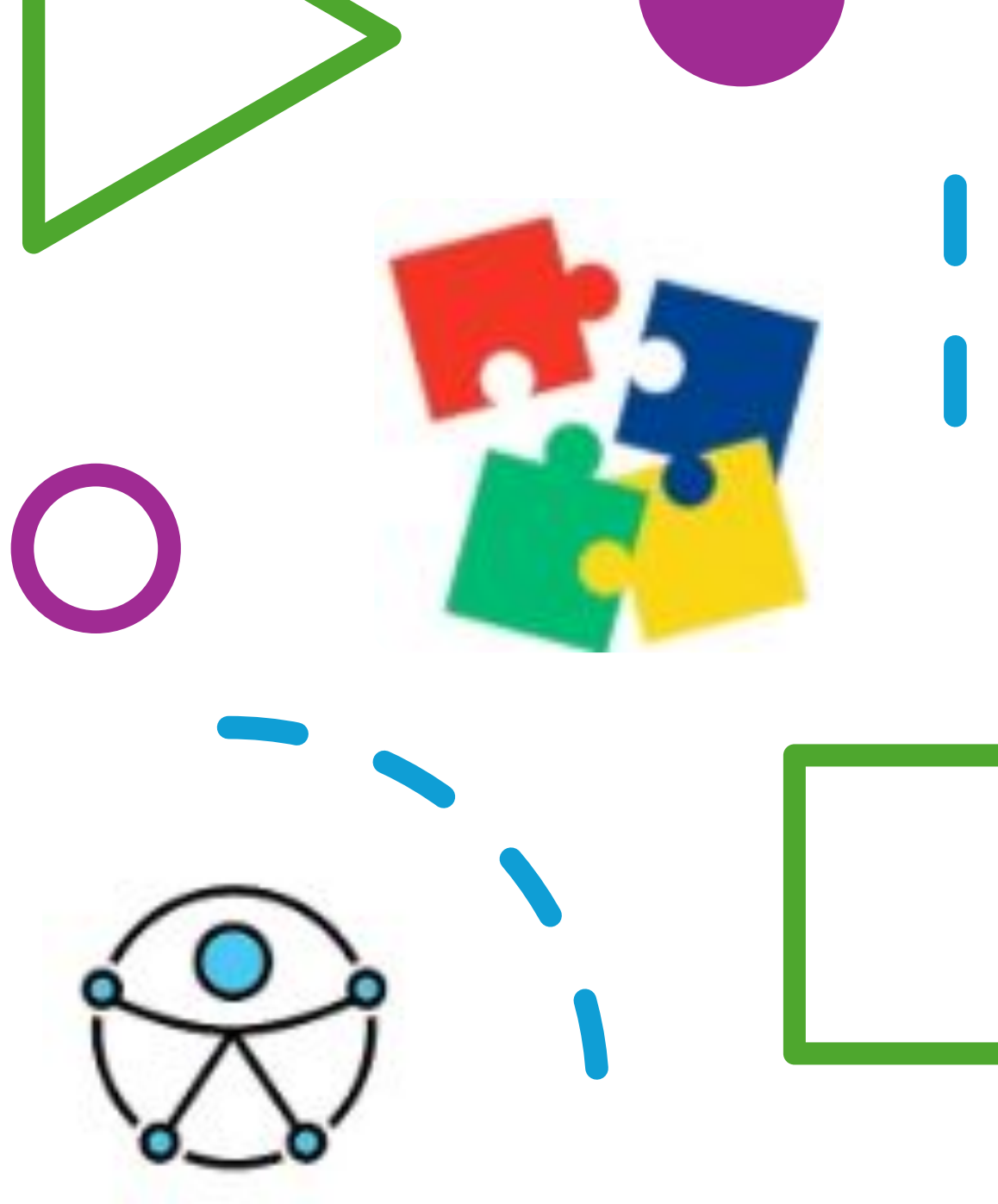
Neurodesenvolvimento: É o processo contínuo de formação, maturação e organização do sistema nervoso central (especialmente o cérebro), que se inicia na fase embrionária e se estende até a idade adulta — por volta dos 25 anos.

Esse processo determina como uma pessoa adquire, aprimora e integra suas funções cognitivas, motoras, emocionais, de linguagem e sociais ao longo da vida.



Transtorno do Espectro Autista (TEA)

O autismo é um **transtorno do neurodesenvolvimento** de origem majoritariamente neurobiológica e genética. Ele altera a forma como o cérebro processa informações, afetando principalmente a comunicação, a interação social e a percepção do ambiente.





Principais características:

Desafios na comunicação interpessoal (como reciprocidade social, linguagem verbal e não verbal).

Padrões de comportamentos, rotinas, interesses ou atividades restritos e repetitivos.

Alterações no processamento sensorial (hiper ou hipossensibilidade a sons, luzes, texturas ou dor).

O que é importante saber: O autismo é um *espectro*, o que significa que se manifesta de formas muito variadas (de níveis de suporte leves a severos). O funcionamento cognitivo de uma pessoa autista pode ir desde a inteligência acima da média até a presença de deficiência intelectual associada.





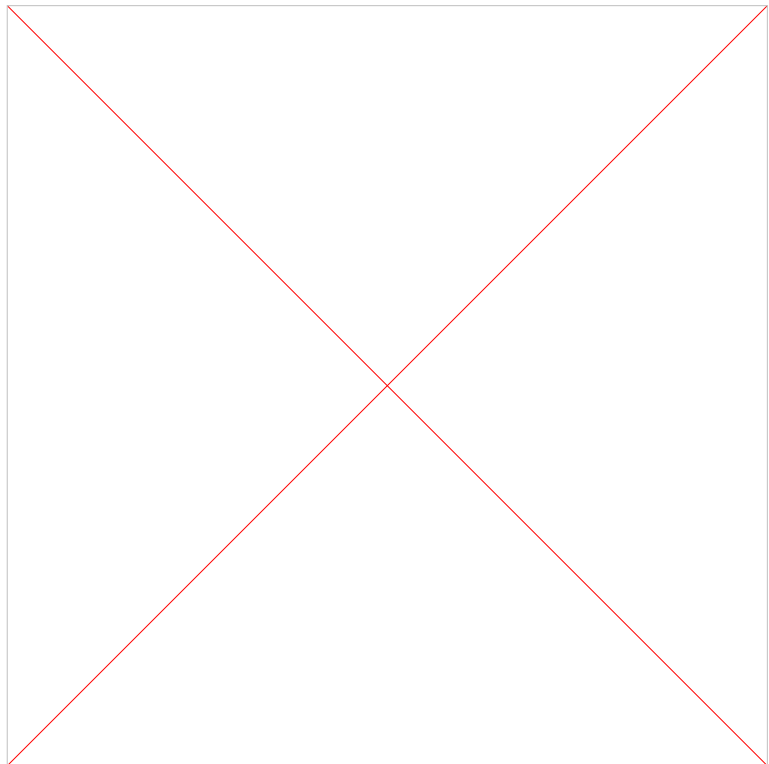
CAUSAS



NÃO EXISTE CAUSA ÚNICA DE AUTISMO

O TEA É UM TRANSTORNO MULTIFATORIAL, OU SEJA, É RESULTANTE DA COMBINAÇÃO DE INFLUÊNCIAS GENÉTICAS, NÃO GENÉTICAS E AMBIENTAIS.

- **Fatores genéticos:** Foi comprovada uma predisposição genética para o autismo. No entanto, não existe um único gene responsável pelo autismo.
- **Mutações genéticas:** Algumas mutações genéticas podem aumentar o risco de autismo. Essas mutações podem ocorrer espontaneamente ou ser herdadas dos pais.





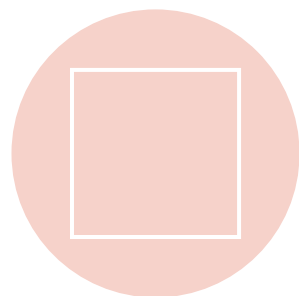
- **Fatores ambientais:** o ambiente também pode influenciar o desenvolvimento do autismo. Exposição a certos agentes químicos, toxinas ou infecções durante a gravidez pode aumentar o risco. Além disso, complicações durante o parto, como falta de oxigênio, também foram associadas ao autismo.
- Alcoolismo
- Obesidade materna
- Nascimento prematuro
- Filho mais velho com TEA
- Idades paterna (50+)
- Idade materna (40+)
- Uso de valproato durante a gestação (estabilizador de humor)
- Diabetes gestacional



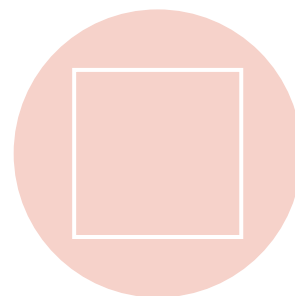
NÍVEIS DO AUTISMO



Nível 1 de Suporte: Geralmente existem dificuldades em relação ao ambiente social, mas consegue ter uma certa autonomia. Necessita de apoio e ajuda apenas em alguns momentos. Fala e conversa normalmente, mas em determinadas situações é corrigido por pequenos erros de linguagem e fala.



Nível 2 de Suporte: Na maioria dos casos não consegue ter boa comunicação verbal e não verbal, não fala todas as palavras e erra frases em alguns momentos. Apresenta comportamentos repetitivos mais frequentes que o nível 1. Dificuldade em iniciar interações sociais, precisando muitas de mediador nessas situações;



Nível 3 de Suporte: Frequentemente não consegue falar de forma satisfatória e na maioria das vezes não fala. Autistas não verbais são considerados de intensidade severa, pois não apresentam requisitos e condições de comunicação verbal. Alta dependência nas AVDs (atividades de vida diária), sociais e capacidade cognitiva

ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS

ESTEREOTIPIAS: Comportamentos repetitivos motores e/ou verbais. Geralmente após um gatilho estressante correlacionado com a ansiedade.

Também podem ocorrer quando estão felizes.

Esses movimentos podem ajudar na organização dos pensamentos, regular o excesso de energia e emocional (sobrecarga sensorial) para a atenção e concentração.

- **RIGIDEZ COGNITIVA:** Dificuldade em adaptar-se a mudanças ou em ver as coisas de perspectivas diferentes.
- Adesão a rotinas e padrões;
- Dificuldade em lidar com a incerteza;
- Pensamento rígido e literal;
- Resistência à mudança;
- Interesses e fixações intensas;
- Dificuldade em generalizar habilidades.



COMPORTAMENTO DISRUPTIVO:

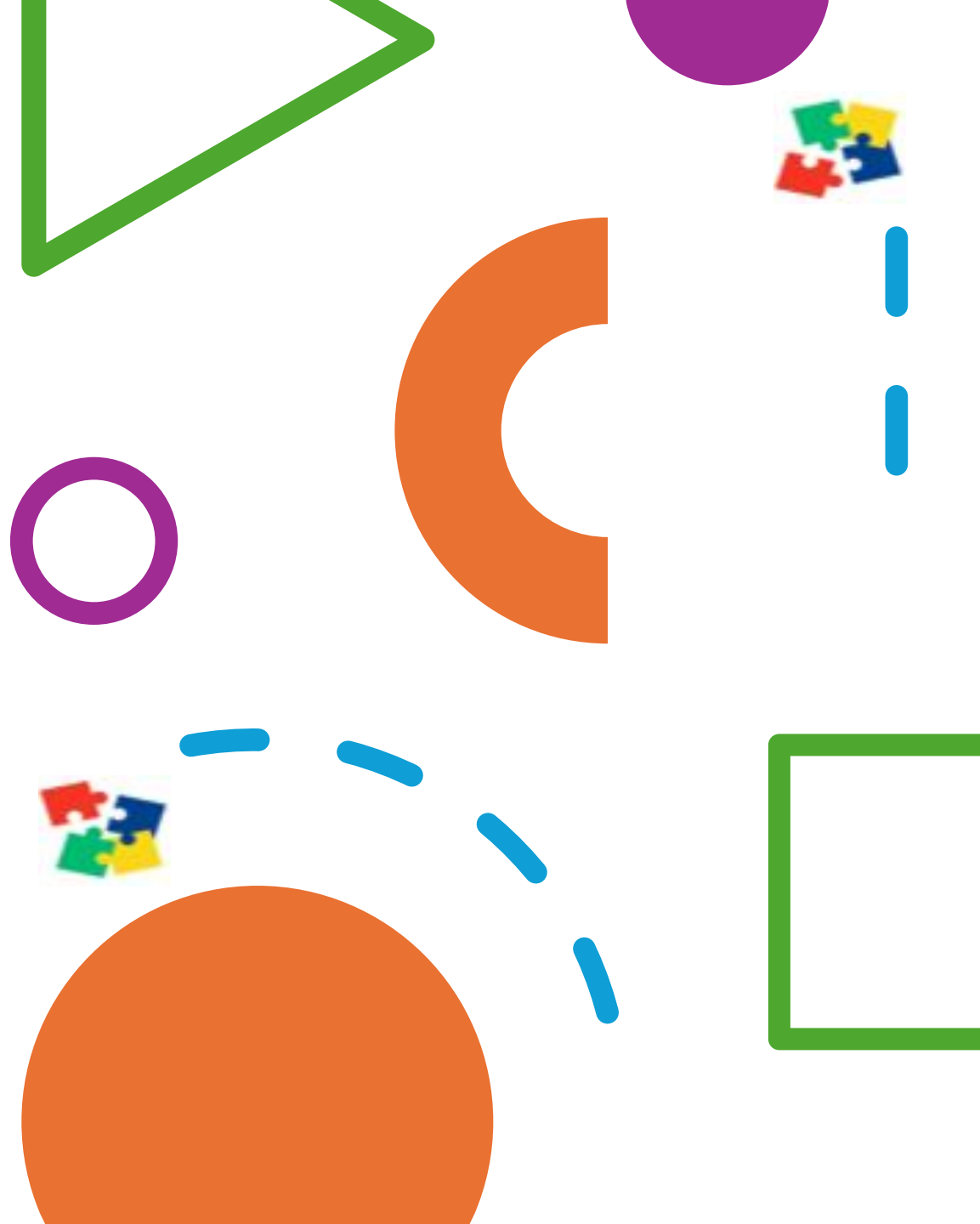
Comportamentos indesejados: fazer birras, bater a cabeça, auto agressão ou agredir outras pessoas;

Estas respostas comportamentais prejudicam a interação social, o aprendizado e seu bem estar.

Aparecem quando querem atenção social, se esquivar ou fugir de demandas, ter acesso a algum reforçador e/ou escapar de alguma estimulação indesejada, geralmente usa dessa estratégia para reverter a situação a seu favor.

CRISES: Ocorre quando a criança é exposta a estímulos sensoriais com os quais não consegue lidar. Gatilhos: luz, vozes, barulho, mudanças de rotina, movimentos, espera prolongada, excesso de informação).

A crise é uma tentativa de reestabelecer o equilíbrio e estabilizar as emoções. É desencadeada pelo sistema nervoso.





Como ajudar o **AUTISTA EM CRISE?**

- Não grite com a criança.
- Tenha paciência!
- Retire os estímulos do ambiente.
- Apague as luzes se sentir que a criança está incomodada.
- Leve a criança para um local mais tranquilo.
- Tire objetos perigosos do local.
- Se livre de barulhos e sons.
- Fale em tom baixo.





ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS

COMO AJUDAR

- **Quadro de rotina;**
- **Antecipação;**
- **Previsibilidade;**
- **Quebra de rotina;**
- **Informação.**

Síndrome de Down

- A Síndrome de Down é uma **condição genética congênita** causada pela presença de três cromossomos 21 (em vez de um par), motivo pelo qual também é chamada de **Trisomia do 21**.





Principais características:

- Características físicas específicas (como hipotonia muscular, olhos amendoados, prega palmar única e menor estatura).
- Ritmo próprio no desenvolvimento motor e na aquisição da linguagem.
- Presença de deficiência intelectual na grande maioria dos casos (geralmente de grau leve a moderado).
- Maior predisposição a algumas questões de saúde física (como cardiopatias congênitas, problemas auditivos ou na tireoide).

O que é importante saber: É identificável por meio do exame de cariótipo. Com acompanhamento precoce (fisioterapia, fonoaudiologia, estimulação cognitiva), a pessoa com Síndrome de Down desenvolve autonomia e habilidades sociais significativas.



Deficiência Intelectual (DI)

A **Deficiência Intelectual (DI)** é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por limitações significativas tanto no **funcionamento intelectual** quanto no **comportamento adaptativo**, originando-se antes dos 18 anos de idade.

O que é importante saber: A DI é uma classificação funcional e pode ter diversas causas (alterações genéticas, complicações no parto, infecções, traumatismos, carências ambientais graves) ou ter causa desconhecida.



O diagnóstico não depende apenas do QI, mas da avaliação conjunta de três pilares:

- **Funcionamento Intelectual:** Capacidades cognitivas como raciocínio, resolução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, julgamento e aprendizagem acadêmica ou pela experiência.
- **Comportamento Adaptativo:** Conjunto de habilidades conceituais, sociais e práticas necessárias para responder às demandas da vida cotidiana e alcançar autonomia.
- **Início no Período do Desenvolvimento:** Os prejuízos devem se manifestar durante a infância ou adolescência.



INCLUSÃO NA IGREJA



POR QUE FALAR SOBRE INCLUSÃO NA IGREJA?

Nova Realidade;

- Aumento significativo de pessoas com Transtornos e deficiências na sociedade;

- O convívio em todos os ambientes: Igreja;

Conscientizar as lideranças e membros Cristãos;

- Suporte à Rede Familiar



Quando você me ensina com amor, eu sou capaz de aprender. Converse com a turma sobre as minhas diferenças e me ajude a participar do grupo.



Se eu quiser pular ou dar uma voltinha pela igreja, isso significa que preciso me regular, e também acontece quando estou feliz.



**Meu comportamento
não é para te
provocar ou testar,
apenas não sei como
fazer de outro jeito,
mas você pode me
ensinar que eu
aprendo.**

@autismonaigreja



**Se você dividir as tarefas
em etapas menores eu
consigo dar conta das
atividades.**

@autismonaigreja



**Com as
acomodações
sensoriais
necessárias,
eu posso me
concentrar
melhor no que
você ensinar.**

@autismonaigreja



**Se você usar os
meus interesses
e hiperfoco, eu
irei gostar das
atividades
propostas!**

@autismonaigreja



COMO INCLUIR E ACOMODAR?



A inclusão e a acomodação de pessoas autistas e de suas famílias no ambiente religioso exigem ações estratégicas em níveis **estrutural, atitudinal e litúrgico**.



1. Acolhimento e Cultura da Comunidade

- **Treinamento das equipes** - Orientar recepção, voluntários, ministério e equipe a reconhecer e respeitar comportamentos e estereotípias, evitando olhares de julgamento ou abordagens invasivas.



Comunicação clara e empática:

Promover palestras ou momentos de conscientização sobre o autismo para a comunidade, reforçando a importância do acolhimento.



Escuta ativa das famílias: Realizar uma breve anamnese ou conversa com os pais/responsáveis para entender os hiperfocos, gatilhos, sensibilidades sensoriais e preferências de comunicação de cada autista.



2. Acomodação Sensorial e Espacial

- **Espaço de desregulação (Sala de Descompressão/acomodação):** Disponibilizar um local calmo, com iluminação mais suave e poucos estímulos sonoros, onde a pessoa possa se autorregular quando o ambiente principal ficar sobrecarregado.



Protetores
auriculares
antirruído;(fones
abafadores de
ruídos)

Mordedores de
silicone;

Objetos
estimulantes
/brinquedos
sensoriais;

Almofadas de peso
para colo;

Massinhas de
modelar, slime,
massa de EVA;

Bolinhas
antiestresse (de gel,
textura de silicone
ou tecido);

Bola suíça (pilates);

Coletes e mantas
de peso
(ponderada)

Almofadas infláveis
de equilíbrio;

Garrafas sensoriais.





Acessibilidade Litúrgica e Pedagógica:



Disponibilizar
cronogramas com
pictogramas (método
PECS ou similar)
mostrando a ordem do
culto

(Ex.: Louvor → Oração
→ Palavra
→ Encerramento)

Informar previamente à
família caso ocorra alguma
mudança brusca na
programação

(batismo, busca de dons).



Adaptação das atividades infantis/de jovens:

Utilizar linguagem direta, concreta e objetiva (evitar metáforas complexas sem explicação).

Oferecer opções de atividades pedagógicas com apoio visual e diferentes níveis de complexidade.

Respeitar o tempo de concentração e a necessidade de movimentação.



Estrutura de Apoio Individualizado



Voluntário de apoio: Designar um voluntário fixo para acompanhar o autista durante as atividades, facilitando a participação social sem sobrecarregar os pais e garantindo previsibilidade.



Flexibilidade e respeito: Compreender que a presença pode variar — em alguns dias a pessoa participará de todo o encontro, em outros precisará sair antes ou permanecer apenas no espaço sensorial.

